



[首頁](#) > [傳染病與防疫專題](#) > [傳染病介紹](#) >

[第四類法定傳染病](#) > [流感併發重症](#) > [疾病介紹](#)

疾病介紹



疾病介紹

季節性流感簡介

季節性流感為感染人類流感病毒所引發之急性病毒性呼吸道疾病，多數國家每年均會發生週期性流行，目前季節性流感係指感染H1N1、H3N2之A型流感病毒，及/或B型流感病毒所造成之流感。

致病原為流感病毒，常引起發燒、咳嗽、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛等，但通常在1週內會康復。流感病毒可分為A、B、C及D四種型別，其中只有A型與B型可以引起大規模的季節性流行，且A型流感病毒除了感染人類外也可感染動物，還可能出現跨物種間的傳播，而B型則至今只曾出現在人類。流感病毒在世界各地常引起週期性且規模大小不一的流行，1977年開始，A型(H1N1與H3N2)及B型流感病毒不斷循環出現在人類的季節性流感流行之中。

雖然在臨床診斷上，流感不容易與其他急性呼吸道疾病區分，例如一般感冒(common cold)、喉炎、支氣管炎、病毒性肺炎與2019年底爆發大流行之嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)等；但一般而言，流感的症狀較一般感冒來得嚴重，病程持續時間也較長，且其他流行病學特徵仍有差異。流感除了爆發流行快速、散播範圍廣泛等特色之外，還會產生嚴重併發症及死亡；尤其是65歲以上長者、幼童、孕婦、免疫功能不全者以及罹患氣喘、心血管疾病、肺臟疾病、肝臟疾病、腎臟疾病、糖尿病等慢性疾病或肥胖(BMI $\geq$ 30)者，可引起細菌性肺炎、病毒性肺炎、腦炎或腦病變、心肌炎或心包膜炎及在使用aspirin之兒童病人引起雷氏症候群(Reye syndrome)等併發症。定期接種流感疫苗，是預防流感併發症最有效的方式。

好發季節

流感為具有明顯季節性特徵之流行疾病，疫情的發生通常具有週期性，而臺灣位處於熱帶及亞熱帶地區，雖然一年四季均有病例發生，但仍以秋、冬季較容易發生流行，流行高峰期多自12月至隔年3月。

致病原

流感病毒(Influenza virus)，可分為A、B、C及D四種型別，其中只有A型及B型可以引起季節性流行，近年主要流行之季節性流感病毒型別以A(H3N2)、A(H1N1)，以及B型流感為主，每季於各地區流行狀況均不同。

傳染窩

人是季節性流感的主要傳染窩；但其他A型流感病毒亞型以禽鳥類(如鴨)及哺乳類(主要是豬)為主要宿主，病毒間可能因基因重組，進一步產生新型流感病毒而造成大流行。

傳染方式

主要是透過呼吸道的飛沫傳染，尤其在密閉空間中，容易經由感染者咳嗽或打噴嚏產生之飛沫而傳染給其他人；另外，由於流感病毒可短暫存活於物體表面，故亦可經由接觸傳染，例如：手接觸到被口沫或鼻涕等黏液污染之物品表面，再碰觸自己的嘴巴、鼻子或眼睛而造成病毒傳染。

潛伏期

通常約1-4天，平均為2天。出現併發症的時間約在發病後的1-2週內。

可傳染期

一般而言約在症狀出現後3-4天內傳染力最強。另研究發現，成年感染者在發病前24-48小時便開始排放病毒，但量較低，病毒排放高峰是發病後24-72小時，直至發病後第5天；但免疫不全者，排放病毒的期間可能達數週或數月；兒童亦較早開始排放病毒，且量較多，時間較久，最長可達21天。

感受性及免疫力

對於首次接觸的流感病毒，大人及小孩均具有相同的感受力，感染後可針對此次感染的病毒抗原產生免疫力，但是免疫力維持的期間及效力，則視病毒抗原微變的狀況及感染的次數而定。雖然流感疫苗可提

供針對疫苗株的血清免疫反應，或是個體先前已感染之相關病毒型別的追加免疫作用，但免疫力會因暴露史或年齡等因素而有所差異。

臨床症狀

感染後所引起症狀之嚴重度與個體免疫力、潛在疾病及年齡等因素有關，其臨床症狀主要包括發燒、咳嗽、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛等。另外，約有10%感染者有噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃道症狀伴隨呼吸道症狀而來。

對大部份健康成年人而言，通常約可在1週內康復，而有些人咳嗽及全身不適之症狀可持續超過2週，少數患者可能出現嚴重併發症，常見併發症為肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等。高危險族群包括65歲以上長者、嬰幼兒及孕婦、免疫功能不全者，以及罹患氣喘、心血管疾病、肺臟疾病、肝臟疾病、腎臟疾病、糖尿病等慢性疾病或肥胖(BMI $\geq$ 30)者。

流感併發重症

為我國第四類傳染病，通報定義係為患者出現類流感症狀後2週內，因併發症(如肺部併發症、神經系統併發症、侵襲性細菌感染、心肌炎或心包膜炎等)需加護病房治療或死亡者，其確定病例為符合通報定義，且流感病毒檢驗結果為陽性者。

預防保健

(一)、衛教宣導

1. 加強個人衛生習慣，勤洗手，避免接觸傳染。
2. 注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，戴口罩及保持社交距離，以避免感染及病毒傳播。
3. 如有出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應戴上口罩並及早就醫，以防因感染流感引起嚴重併發症；生病時不上班不上課，盡量在家休息，減少出入公共場所；如有外出，請記得戴上口罩，並注意咳嗽禮節，於咳嗽或打噴嚏時，以手帕或衣袖捂住口鼻，避免病毒傳播。
4. 如出現呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆時，應提高警覺，儘速/轉診至大醫院就醫。

(二)接種疫苗：

預防流感最好的方法就是施打流感疫苗，65歲以上長者、嬰幼兒等高

危險群尤應接受疫苗接種，以防感染流感引起之併發症。一般而言，流感疫苗的保護力約6個月後會逐漸下降，必須每年接種1次。完整接種後至少約需2星期的時間可產生保護力。

治療照護

感染流感病毒後，大多數患者可自行痊癒，故針對流感患者之治療方法仍以支持療法為主，或可視病況給予抗病毒藥劑治療。目前用於治療流感之抗病毒藥劑，以神經胺酸酶抑制劑為主，包括Oseltamivir (Tamiflu®，克流感、Eraflu®，易剋冒膠囊或速剋流口服懸液用粉劑)，Zanamivir (Relenza®，瑞樂沙)，及Peramivir (Rapiacta®，瑞貝塔)等，可用於治療或預防A型及B型流感。抗病毒藥劑應儘可能於發病後48小時內投予效果最好，不需等到實驗室檢驗確診為流感才給藥，也不應以流感快速檢驗結果作為用藥之唯一依據。然對於症狀嚴重或有併發症等高危險族群，即使超過48小時給藥仍具有效益。克流感、易剋冒及速剋流為口服藥，適用於兒童(包含足月新生兒)及成人，未滿13歲且體重40公斤以下者及腎功能受損病人使用時須調整劑量。瑞樂沙為乾粉吸入劑型，投予途徑為經口吸入呼吸道，適用於5歲(含)以上兒童及成人，不需依體重調整劑量。瑞貝塔為靜脈注射劑型，適用於1個月大以上兒童及成人，兒童及腎功能不良病患使用時需調整劑量。

最後更新日期 2023/12/26